

Динамика онкологической заболеваемости молочной железы и женских половых органов по г. Алматы.

Югай Т.А.¹, Дуненова Г.А.¹, Акимжанова С.М.¹,
Садыкова Т.Т.², Косаева Т.Г.¹

Городской онкологический диспансер¹,

Казахский национальный медицинский университет им.Асфендиярова², Алматы

Профилактика, раннее выявление и лечение злокачественных опухолей является одним из важнейших разделов современной медицины. Анализ заболеваемости злокачественными новообразованиями играет огромную роль для разработки перспективных планов технического и лекарственного обеспечения, планирования комплекса противоопухолевых мероприятий.

Проведен анализ онкозаболеваемости локализаций органов женской половой сферы по г. Алматы за период 2007-2010 гг.

Рак молочной железы является лидером в онкопатологии среди женского населения Казахстана последние десятилетия, так же, как и в большинстве развитых стран. Согласно показателям онкологической службы Республики Казахстан в 2009 году РМЖ занял первое ранговое место в стране по заболеваемости и смертности в структуре онкозаболеваний женской репродуктивной сферы.

По сравнению с республиканскими статистическими данными максимальный показатель заболеваемости раком молочной железы был зарегистрирован в г.Алматы.

Заболеваемость раком молочной железы среди населения города Алматы в 2010 году составила 33,9 на 100 тысяч населения, тогда как в 2009 году – 33,2. В сравнении с республиканскими показателями в 2009 году - 21,0. Этот показатель занимает лидирующее место в структуре общей онкозаболеваемости с 2004 года, а в структуре онкогинекологической патологии сохраняет первое ранговое место уже последние 10 лет. С ростом заболеваемости рака молочной железы отмечено некоторое повышение показателя запущенности. В 2010 году он составил 25,3% при показателе 2009 года – 25%.

Остается высоким удельный вес больных с IV стадией раком молочной железы – 6,1%. Повысилась смертность от рака молочной железы – 15,6 на 100 тыс. женского населения (13,8 в 2009 году). В общей структуре смертности от рака молочной железы занимает второе место после рака легкого. По-прежнему, остается высокой заболеваемость рака молочной железы в возрастной группе от 40 до 59 лет – 48,5%. Обычно эта возрастная группа является наиболее активной при самообращении и наиболее диагностируемой за счет проводимых медико-социальных программ. Тревожным же является то, что 44% заболевших – это женщины в возрасте от 60 лет и старше, из них 22% - старше 70 лет. Обычно эта группа женщин недостаточно охвачена профилактическими программами и выявляется в большей степени при самообращении.

Рак шейки матки в структуре злокачественных опухолей

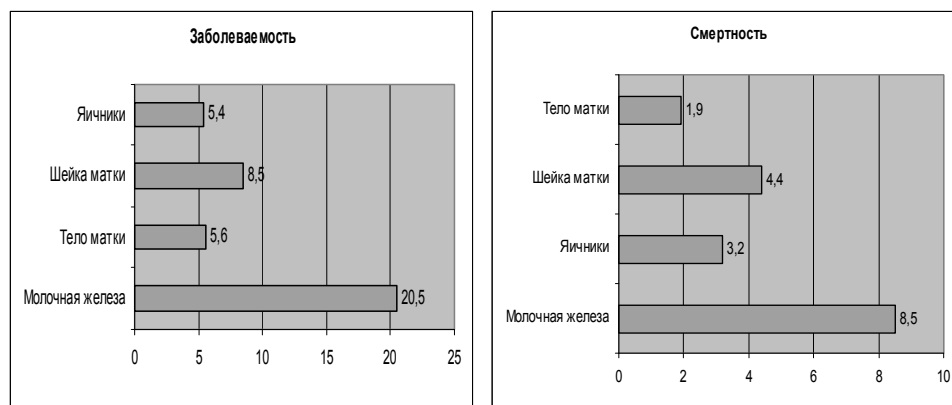


Рисунок 1. Структура заболеваемости и запущенности рака женской репродуктивной сферы РК за 2009 г.

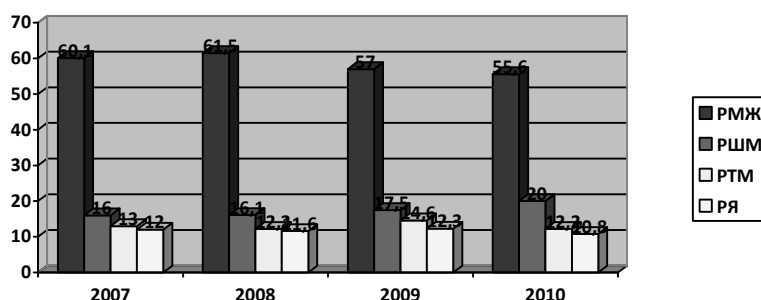


Диаграмма 1. Динамика структуры женской заболеваемости основными злокачественными новообразованиями репродуктивной системы г. Алматы за 2007-2010 гг (%)

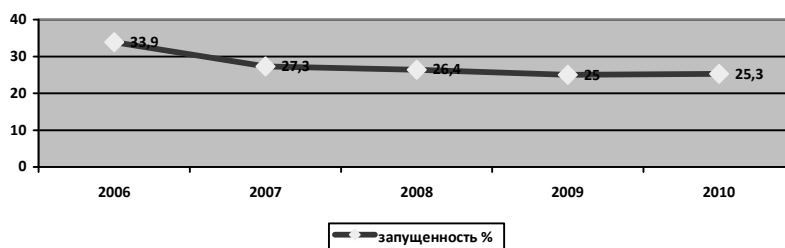


Диаграмма 2. Динамика запущенности рака молочной железы за 2006-2010 гг.

репродуктивной системы женщин занимает одно из ведущих мест, уступая только раку молочной железы. По данным ВОЗ ежегодно в мире выявляется около 470 000 новых случаев РШМ, что составляет 14,2% от всех злокачественных новообразований у женщин.

В Алматы рак шейки матки занимает 3 место в структуре заболеваемости женского населения после рака молочной железы и рака кожи, и 7 место в структуре заболеваемости всего населения. В 2010 отмечен рост заболеваемости рака шейки матки.

Отмечается высокий удельный вес больных РШМ репродуктивного возраста – 48% от всех заболевших. Увеличение числа

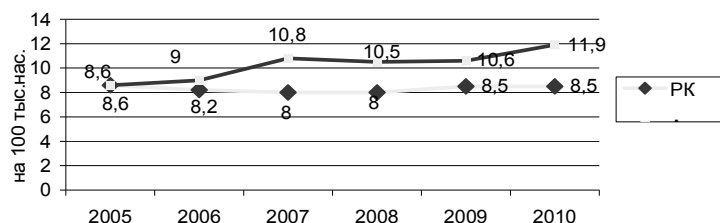


Диаграмма 3. Динамика заболеваемости РШМ за 2005-2010гг на 100 тыс. населения



Диаграмма 4. Динамика запущенности РШМ за 2006-2010гг.

заболевших фертильных женщин является весьма тревожным фактом, так как данный контингент пациенток представляет собой не только репродуктивно значимую часть женского населения, но и активную в социальном отношении группу. 40% первично выявленных больных в возрасте от 50 до 69 лет. Эта группа женщин часто оказывается вне рамок диспансеризации по фоновым заболеваниям и соответственно, у них наиболее часто встречается распространенная форма рака.

В 2007-2010 году продолжена государственная программа обследования женщин с целью выявления рака шейки матки на ранних формах. При профилактических осмотрах и взятии 53525 цитологических мазков целевой группы выявлено только 36 больных раком шейки матки, что составило 0,07% выявляемости. По сравнению с предыдущими годами отмечается некоторая положительная динамика: в 2009 году показатель выявляемости рака шейки матки у целевой группы составил 0,03%. Это свидетельствует о повышении качества проводимой программы скрининга, хотя говорить о значительных положительных сдвигах еще не приходится. В свою очередь, несмотря на визуально доступную локализацию злокачественной опухоли и большие возможности ранней диагностики данного заболевания, остается высоким процент запущенных форм (III-IV стадии), составляющих в Казахстане в среднем 22,7%, в Алматы – 10,2%.

Смертность от данной патологии занимает одно из первых мест, превышая в г.Алматы республиканские показатели. Это свидетельствует о позднем диагностировании рака шейки матки, что в свою очередь обуславливает неблагоприятный прогноз.

Для своевременного выявления рака шейки матки необходимо улучшить работу по проведению профилактических осмотров женщин с обязательным цитологическим исследованием, а также проводить работу по диспансеризации и лечению больных с фоновыми заболеваниями шейки матки.

Рак тела матки (РТМ) относится к гормонозависимым опухолям и сравнительно редко встречается в Республике Казахстан, хотя довольно широко распространен в экономически развитых странах. Он насчитывает около 5% от числа всех опухолей, развивающихся у женщин. В структуре онкогинекологической заболеваемости в нашей республике в 2009 году находился на 5 месте, составляя 5,2/100.000 женщин. По городу Алматы отмечено увеличение показателя заболеваемости раком тела матки: в 2010 году составил 6,9 на 100 тыс. населения, в сравнении с показателем заболеваемости в 2009 году - 6,5.

Существенная роль обменно-эндокринных нарушений в организме обуславливает развитие гиперпластических про-

цессов, а также возникновение на этом фоне неопластической трансформации. Нарушение в репродуктивном и энергетическом гомеостазе могут играть ключевую роль в развитии гиперпластических состояний и рака эндометрия, и служить факторами риска развития данного вида опухоли. Поэтому активное выявление предраковых процессов путем обследования групп риска больных с нейроэндокринными нарушениями может предотвратить развитие рака тела матки.

Рак яичников. Проблема диагностики и лечения злокачественных новообразований яичников является одной из наиболее актуальных в современной онкологии. Ежегодно в мире регистрируются 165000 больных раком яичников и 101000 из них погибают от прогрессирования заболевания. В Казахстане за последние 10 лет наблюдается незначительный рост заболеваемости данной локализации опухолей репродуктивной системы. Частота рака яичников в РК за 2009 год составляет 5,1 на 100 тыс. женского населения. Проведенный анализ заболеваемости раком яичников за три года по г. Алматы показал, что уровень заболеваемости остается относительно стабильным. Однако за последнее десятилетие

отмечено некоторое снижение заболеваемости раком яичников. По городу Алматы показатель заболеваемости в 2010 году составил 5,8 на 100 тыс. женского населения (6,5 на 100 тыс. женского населения в 2009 году).

Однако, учитывая клинические особенности течения рака яичников, даже такая динамика снижения заболеваемости не улучшает онкоситуацию в целом.

Весьма актуальной остается проблема своевременной диагностики рака яичников. До настоящего времени у 75% больных раком яичников заболевание выявляется на поздних стадиях с 5-летней выживаемостью не более 15-20%. Большинство больных поступают в онкологические учреждения с запущенными стадиями опухолевого процесса яичников – в среднем 46,5% больных со злокачественными опухолями яичников с III стадией и 21% больных с IV стадией заболевания. Причины позднего выявления опухолей были обусловлены как бессимптомным течением заболевания на ранних стадиях, так и врачебными ошибками в диагностики из-за недостаточного знания семиотики злокачественных опухолей, длительного наблюдения за больными без уточненного диагноза, недостаточного использования всего возможного арсенала диагностических методов.

Грозным признаком недостаточной онконастороженности врачей общей лечебной сети являются участвовавшие случаи поступления в отделение онкогинекологии женщин с нерадикальным объемом операции их в ЛПУ города. Как правило, прогноз течения заболевания этих пациенток неблагоприятен, ввиду обширного интраоперационного обсеменения рака. Участились случаи нерадикальных операций, проводимых лапароскопическим методом, хотя малейшее подозрение на рак яичников является абсолютным противопоказанием к лапароскопической хирургии.

Учитывая объективные трудности дифференцированной диагностики рака яичников (отсутствие патогномичных признаков), при появлении жалоб со стороны желудочно-кишечного тракта, наличие асцита, болей в животе неопределенного характера, пальпируемых образований в брюшной полости, необходимо исключить рак яичников. В связи с прослеживающейся тенденцией «омоложения» рака яичников необходимо обратить внимание врачей общей лечебной сети на состояние здоровья женщин в репродуктивном периоде.

Выводы

Постоянный рост заболеваемости рака молочной железы является предсказуемым и необратимым вследствие многих причин, прежде всего высоких социальных психоэмоциональных

факторов и неблагоприятной экологической обстановки.

Запущенность рака молочной железы остается на прежнем уровне, что свидетельствует о необходимости повышения качества реализуемой скрининговой программы, строгого соответствия принятой в стране лечебно-организационной тактики, вследствие прямой пропорциональности эффективности лечения РМЖ и прогноза от стадии заболевания.

Заболеваемость раком шейки матки в г.Алматы остается стабильно высокой. Снизился удельный вес больных с запущенными стадиями заболевания, одной из причин которой явилось улучшение качества проводимого онкоцитологического скрининга, в том числе оппортунистического.

Своевременное, адекватное лечение больных с фоновыми

и предраковыми заболеваниями шейки матки позволит снизить процент заболеваемости и запущенности РШМ.

Учитывая малосимптомность начальных стадий рака яичников необходимо активное выявление этой патологии – регулярные гинекологические осмотры с применением дополнительных методов исследования – УЗИ органов малого таза в качестве скрининг-метода в группах риска по данному заболеванию. Больные с любыми опухолями яичников, в том числе при безэффективности консервативного лечения, должны подвергаться оперативному лечению с использованием метода экспресс-биопсии.

Динамика онкологической заболеваемости молочной железы по Республике Казахстан

Сактаганов М. И., Абдукаримова Д. Х., Джакипбаева А. К.,

Танжарыков Е. С., Куланбаев Е. М., Сметов С.Б

Городской онкологический диспансер г. Алматы,

Казахский национальный медицинский университет им. Асфендиярова

Одними из самых актуальных вопросов в онкологии являются первичная и вторичная профилактика, ранняя диагностика, усовершенствование методов лечения злокачественных опухолей. Изучение динамики заболеваемости, смертности от злокачественных новообразований необходимо для оценки результатов скрининговых программ и разработки плана мероприятий для их улучшения.

Рак молочной железы (РМЖ), по данным ВОЗ, занимает первое место в структуре онкологической заболеваемости у женщин. В Республике Казахстан в 2010 году РМЖ занял первое место в стране по заболеваемости и смертности в структуре онкозаболеваний женской репродуктивной сферы.

Проведен анализ онкозаболеваемости раком молочной железы по Республике Казахстан и по г.Алматы за период 2005-2010 гг. (Диаграмма 1).

Отмечается некоторое повышение заболеваемости РМЖ в РК с 19,5 до 20,6‰. В г.Алматы заболеваемость РМЖ остается достаточно высокой и стабильной 33,0‰-33,5‰, в последние годы РМЖ в г.Алматы занимает первое место в структуре общей онкологической заболеваемости.

С 2005 по 2010 гг. общая смертность от РМЖ по РК несколько снизилась с 9,1 до 8,7‰, в г.Алматы немного повысилась с 13,0 до 14,2‰.

Важным показателем выполнения скрининговых программ является удельный вес ранних форм РМЖ (диаграмма 2).

В период с 2005 по 2010 гг. по Республике Казахстан и г.Алматы удельный вес ранних форм РМЖ повысился с 61% (59,9%) до 74,1% (74,6%) соответственно.

Удельный вес запущенных форм по РК и г.Алматы несколько снизился с 9,9% (7,2%) до 6,9% (6,1%) соответственно.

В г.Алматы с 2009 года проводится маммографический скрининг женщин декретированного возраста. Данные маммографического скрининга представлены в таблице № 1.

По данным 10 месяцев 2011 г., маммографический скрининг, проводимый в поликлиниках г.Алматы выявил 33

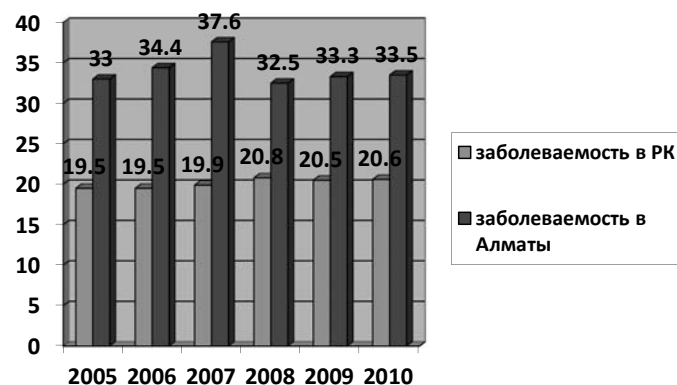


Диаграмма 1. Структура заболеваемости раком молочной железы в РК и в г.Алматы за 2005-2010 гг.

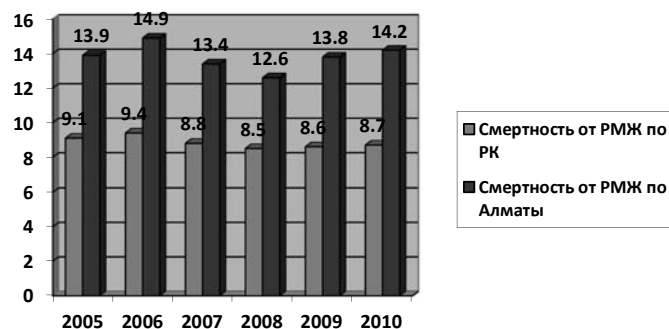


Диаграмма 2. Структура смертности от рака молочной железы в РК и в г.Алматы за 2005-2010 гг.

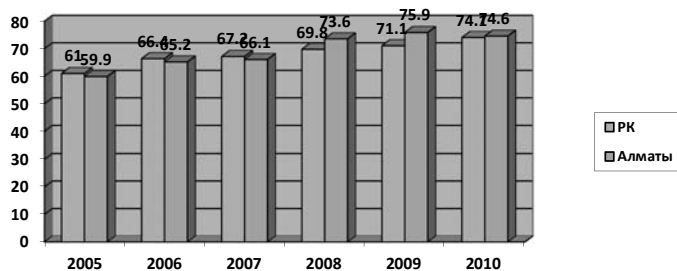


Диаграмма 3. Динамика удельного веса ранних форм рака молочной железы в РК и г.Алматы за 2005-2010 гг. (%)

Годы	Обследовано женщин маммографически	Из них выявлен РМЖ по маммографии
2009	43834	79
2010	42367	16
2011	38067	33

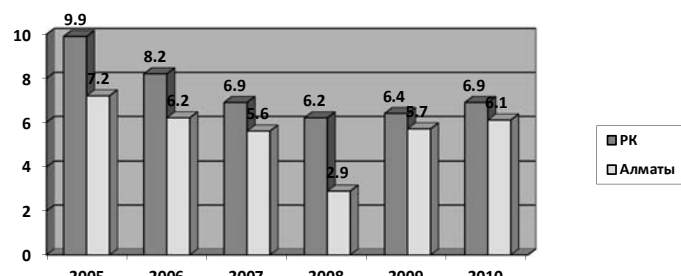


Диаграмма 4. Динамика удельного веса запущенных форм рака молочной железы в РК и г.Алматы за 2005-2010 г. (%)

женщины со злокачественной опухолью молочной железы, из них: с I стадией – 7 (21%), со IIa – 18 (55%), со IIb – 4

(12%), с III – 4 (12%), с IV – 0, т.е. удельный вес ранних форм составил 76%.

Выводы

Заболеваемость РМЖ в РК остается по-прежнему высокой (19,5- 20,6‰), находится на 1 месте в структуре онкологической заболеваемости у женщин. В г.Алматы заболеваемость по РМЖ остается одной из самых высоких в РК (33‰-33,5‰), занимает 1-е место в структуре общей онкологической заболеваемости.

Применение маммографического скрининга способствует повышению удельного веса ранних форм РМЖ, что несомненно приведет к повышению эффективности лечения РМЖ и улучшению прогноза заболевания.

Полимодальное лечение послеоперационной боли

Денисенко Э.В.

Отделение анестезиологии и реанимации онкодиспансера г. Алматы

В настоящее время одной из актуальных проблем послеоперационного периода остается поиск более эффективных методов обезболивания.

Операционная травма и сопровождающая её боль является пусковым механизмом стресс-реакции. Будучи мощным стимулятором вегетативной нервной системы, боль опосредованно оказывает отрицательное воздействие на функции различных органов и систем. Напряжение функций этих систем, прежде всего кровообращения и дыхания, проявляется повышением давления, тахикардией, нарушением сердечного ритма, учащением дыхания и т. д. Конечным звеном этих реакций является нарушение периферического кровообращения, которое может перечеркнуть весь труд хирурга.

К другим клиническим проявлениям стресс-реакции относятся снижение двигательной активности, «вынужденное» положение тела, неспособность откашливать мокроту и глубоко дышать.

Наконец, неэффективное обезболивание в первые сутки послеоперационного периода, возможно, служит одной из причин формирования впоследствии хронического болевого синдрома (ХБС), который может сохраняться у пациентов длительное время.

Углубленное изучение патофизиологии послеоперационного периода привело к тому, что первоначальная вера в адаптационную мудрость организма, когда его стресс-реакция на травму рассматривалась как необходимый для выживания компенсаторный механизм, сменилась осознанием необходимости максимального подавления стресс-ответа. Отсюда следует вывод, что адекватная анальгезия может и должна улучшить исход хирургического лечения.

Классический метод обезболивания наркотиками блокирует центральные механизмы болевого синдрома, но не устраняет причину, имея массу нежелательных побочных эффектов. Последние десятилетия всё больше внимания обращается на изучение периферических механизмов возникновения боли и способы её устранения. Современное представление о механизмах возникновения болевого синдрома и последствиях для организма в целом следующее: при обширной травме тканей медиаторы, выделяющиеся в месте повреждения (серотонин, цитокины, лейкотриены, простагландины), стимулируют полимодальные ноцицепторы, которые вновь усиливают выделение медиаторов, снижая таким образом порог болевой чувствительности (первичная гипералгезия). Местный отек тканей вследствие нарушения проницаемости капилляров под воздействием гистамина, брадикинина еще более сенситизирует рецепторы (вторичная гипералгезия).

В настоящее время одной из актуальных проблем послеоперационного периода остается поиск более эффективных методов обезболивания.

На практике применен метод полимодального послеоперационного обезболивания, что в условиях онкологического диспансера г.Алматы позволило уменьшить расход наркотических анальгетиков и улучшить результаты лечения онкобольных.

Локальный воспалительный процесс является причиной формирования системного ответа на повреждение, что проявляется увеличением концентрации белков острой фазы (С – реактивный белок, фибриноген, плазменный альбумин). Затем происходит активация ряда медиаторных систем (кининовая, системы комплемента, липидных медиаторов и цитокинов).

Таким образом, выраженный воспалительный ответ для организма в большей степени является разрушительным, нежели защитным. Первые двое суток послеоперационного периода являются определяющими для прогноза исхода хирургического лечения и предъявляют особые требования к выбору метода и качеству послеоперационного обезболивания.

Исходя из этого представления о периферическом механизме боли, формируются и современные схемы профилактики и лечения послеоперационного болевого синдрома. Патогенетически оправдано использование анальгетиков периферического действия из ряда нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), ингибирующих медиаторы боли и модуляторы воспаления. Доказана и эффективность препаратов типа контрикала – ингибитора синтеза брадикинина.

Хорошо известно и очень важно то, что боль, вызванная хирургическим повреждением тканей, сопровождается спазмом гладкой мускулатуры. Механизм возникновения спазма достаточно сложный, но при рассмотрении патогенеза боли в современной литературе этой взаимосвязи уделяется мало внимания.

Неоспоримо и то, что спазм порождает или усиливает боль. Интересно также то, что связь боли и спазма замыкается на уровне спинного мозга и не контролируется головным мозгом. Образуется замкнутый круг, поддерживающий болевую импульсацию, отягощающую течение послеоперационного периода.

Исходя из этого, становится логичным то, что наркотики не всегда эффективны при спастических болях, мы просто ослабляем восприятие боли за счёт центрального, седативного эффекта, но не устраняет спазм. Эта седация, с одной стороны,

полезна. Но она же и является минусом применения наркотиков в послеоперационном периоде, когда для профилактики осложнений требуется ранняя активизация больных. Другой минус – угнетение дыхания, функций желудочно-кишечного тракта.

Применяя НПВП – периферический анальгетик, мы уменьшаем болевую импульсацию и ингибируем гуморальные факторы боли, но кардинально не устраняем спазм. Возможно, именно с этим связана недостаточная эффективность НПВП после операций на органах желудочно-кишечного тракта, где спазм гладкомышечной мускулатуры имеет большое значение в генерации боли.

Используя принцип полимодальности, на кафедре анестезиологии и реаниматологии АГИУВ теоретически было обосновано применение комбинации НПВП и миотропного спазмолитика (Но-шпа) в послеоперационном периоде (2006г).

Современные концепции послеоперационного обезболивания определяются желанием как можно меньше использовать наркотические анальгетики. Исходя из этого, было предположено, что предлагаемая комбинация позволит реже применять наркотики, достигнув их уровня эффективности при использовании НПВП.

Рассмотрев проблему послеоперационного обезболивания, были сформулированы основные принципы современных подходов к её решению:

Максимальное ограничение использования наркотических анальгетиков и их аналогов (только по необходимости и при неадекватности других методов обезболивания).

Широкое использование современных НПВП, обладающих эффективным действием на разные компоненты болевого синдрома. При грамотном и кратковременном использовании риск развития осложнений со стороны ЖКТ минимальный.

Многокомпонентность послеоперационного обезболивания – использование нескольких препаратов, действующих на различные компоненты болевого синдрома.

Превентивное обезболивание – предупреждение возник-

новения боли – введение препаратов до развития болевого синдрома, по часам.

Данная концепция была реализована на практике в следующем виде. Во время операции вводятся ингибиторы гуморальных факторов боли (например – контрикал 50 тыс ЕД). Сразу после операции, ещё до пробуждения, вводится НПВП и Но-Шпа (базовая анальгетическая терапия). Далее эта комбинация вводится с интервалом в 6-8 часов, вне зависимости от наличия боли. Кратность введения зависит от применяемого НПВП – его суточной разрешённой дозировки. Наркотические анальгетики (промедол, стадол и т.п.) вводятся только по требованию – при неэффективности базовой анальгетической терапии.

На практике предложенная схема послеоперационного обезболивания показала высокую эффективность. При достаточном уровне обезболивания расход наркотических анальгетиков после неполостных операций уменьшился на 76%, после полостных малотравматичных – на 69%, после объёмных травматичных вмешательств на желудке и пищеводе – на 62%.

Литература

- Лебедева Р.Н., Никода В.В. *Фармакотерапия острой боли.* – М., 1998.
- Н.А. Осипова. Антиноцицептивные компоненты общей анестезии и послеоперационной анальгезии. // *Анестезиология и реаниматология*, № 5, 1998.
- Савенков П.М. и др. Применение но-шпы у больных с грудной жабой. // *Кардиология*, 1968, №8, с.46-48.
- Чурсин В.В., Тулеусаринов А.М., Веселова Т.В. *Лечение болевого синдрома у онкологических больных. Материалы IV съезда онкологов, рентгенологов и радиологов РК, - Алматы, - 2001г, -С. 379-384.*
- Ферранте Ф.М. и др. *Послеоперационная боль. Перевод с английского проф. Карачунского М.А., Мельниковой Е. В., -М., - 1998.*